

21 - 03-L'expectoration et la vomique - Pr A. BENJELLOUN

Bismillahirrahmanirrahim, salatous salam ala rasoulillah wa ali wasrabihi ajma'in Chers étudiants, nous allons continuer notre série de simbiologie respiratoire. Nous avons vu l'interrogatoire et nous avons commencé les symptômes respiratoires, les signes fonctionnels. Le premier symptôme, nous avons vu la toux.

A présent, nous allons voir un corollaire de la toux, c'est l'expectoration. Donc on va traiter de l'expectoration et la vomique. Quels sont les objectifs de ce cours ? On va définir l'expectoration, définir la bronchorrhée, voir la différence entre l'expectoration et la bronchorrhée, décrire le mécanisme de l'expectoration, analyser les caractéristiques sémiologiques, citer les principales causes des expectorations, définir la vomique, décrire les différents types de vomique et ainsi que leurs causes.

Cela va se faire selon ce plan, d'abord tout un tas de définitions, le mécanisme des expectorations, leur description, l'orientation diagnostique, les types de vomique et les causes des vomiques. L'expectoration est une expulsion de sécrétions anormales présentes dans l'arbre trachéobronchique par les voies respiratoires et la bouche au cours d'un effort de toux. La toux n'est pas obligatoire, on peut avoir des expectorations, surtout lorsqu'elles sont abondantes, on peut avoir des expectorations en l'absence de toux.

Quel est le diagnostic différentiel ? C'est bien entendu le crachat. Le crachat c'est l'expulsion de salive provenant de la cavité buccale ou bien l'expulsion de sécrétions provenant de la cavité O.R. L'expectoration sort du thorax, donc vraiment de l'arbre trachéobronchique et des poumons. Qu'est-ce qu'une bronchorrhée ? La bronchorrhée c'est une expectoration mais abondante, c'est une production quotidienne de sécrétions de plus de 100 ml.

On les voit surtout dans certaines pathologies comme les dilatations des bronches et les bronchites chroniques du fumeur. La vomique est une expectoration d'un genre particulier, c'est une évacuation brutale au cours d'un effort de toux, d'une collection purulente, abondante. C'est du pus fétide mélangé ou non avec du sang, on les voit surtout dans les abcès pulmonaires.

Et vous avez l'hydatidose, elle est beaucoup plus rare que les autres. C'est une vomique mais c'est le contenu d'un kyste hydatidique. La couleur est très claire, c'est une couleur eau de roche.

Elle peut être purulente ou hémorragique, c'est-à-dire du pus mélangé à du sang. Quel est le mécanisme de ces expectorations ? Les produits qui sont inhalés, bronchiques, soit des toxiques, soit un corps étranger, des bactéries, etc., ils sont éliminés par la toux, par le tapis mucociliaire et la clairance alvéolaire. Les alvéoles ont un mécanisme qui va dégager les expectorations pour évacuer tous les déchets qui existent à l'intérieur des voies respiratoires.

De façon physiologique, le mucus recouvre la muqueuse trachéobronchique. C'est un mélange de liquides alvéolaires, de sécrétions cellulaires et de transsudat. Il existe deux couches qui

sont situées à l'extrémité des cils vibratiles des cellules ciliées.

Vous avez une couche profonde, c'est ce qu'on appelle la phase sonne, elle est fluide. Et vous avez une couche superficielle qui est beaucoup plus dure, qui est géiforme, c'est la phase gel. Il existe une épuration permanente des voies aériennes par le mouvement des cils et par la toux.

Cette clairance peut être diminuée dans certaines maladies comme la maladie asthmatique, la bronchite chronique, la bronchiectasie et la mucoviscidose. Ceci est dû à une inflammation endobronchique qui va retarder ou qui va mettre en panne cet ascenseur mucociliaire. Ce qui fait qu'il va y avoir une accumulation de sécrétions et donc des expectorations plus abondantes que d'habitude.

Le mécanisme est simple, vous avez une agression des voies aériennes, augmentation de la sécrétion de mucus par les cellules glandulaires et l'excès de mucus est éliminé par la toux. Comment on décrit les expectorations ? Tout d'abord le mode de survenue, est-ce que le caractère est aigu ? Est-ce que ces expectorations datent de quelques jours ou de quelques semaines ? Auquel cas il faut rechercher surtout une pathologie infectieuse. Ou il s'agit d'expectorations chroniques, des mois, des années.

Auquel cas il faut chercher des bronchiectasies, il faut chercher une bronchite chronique. Et quel est le contexte de survenue ? Est-ce qu'il existe une infection, une cardiopathie, un contexte allergique comme les expectorations désastmatiques, les expectorations matinales qu'on appelle les crachats perdus de la haine ? Quelle est la fréquence de ces expectorations, leur horaire et la périodicité ? Par exemple, les bronchiectasies et les bronchites chroniques, les expectorations sont surtout matinales. Lorsque vous avez une hyperactivité bronchique ou un asthme, les expectorations sont saisonnières, soit automnales, soit printanières, soit hivernales.

Est-ce que ces expectorations sont spontanées ou provoquées par certaines positions ou situations ? Cela va aider au diagnostic. Et il faut savoir quantifier sur un verre gradué. On le fait surtout lors des bronchiectasies.

Une expectoration excessive est supérieure à 30 millilitres par jour. Et on parle de branqueries à partir de 100 millilitres par jour. On juge de la viscosité de l'expectoration en fonction de son adhérence au verre gradué.

Il faut savoir que certaines expectorations, comme celle d'un tuberculeux, collent au verre gradué. Elles sont très difficiles à expulser. On peut connaître la cause en fonction de la couleur.

Une couleur blanchâtre, visqueuse ou grisâtre, c'est la couleur muqueuse. Purulente, une expectoration purulente est plutôt verdâtre. Purulente, elle est plutôt jaunâtre, compacte, avec un petit peu de vert.

Serreuse, elle est plutôt transparente, fluide et aérée, comme on en voit dans les cardiopathies

ou la maladie asthmatique. Perlée, c'est de petites perles observées surtout dans l'asthme. Ce qu'on appelle les crachats perlés de la haine qui sont matinaux.

Et puis sanglante, c'est une expectoration muqueuse triée de sang. C'est ce qu'on appelle un crachat hémotoïque. C'est du sang mêlé à l'expectoration.

Parfois, vous avez une hémoptysie de sang pur. Dans ces cas-là, il faut chercher soit la tuberculose, une aspergylose, des bronchectasies parfois, ou alors un cancer dans un contexte de tabagisme chronique. L'orientation diagnostique en fonction du caractère aigu ou chronique.

Dans l'essai expectoration aiguë, si vous avez un contexte infectieux, si vous n'avez pas d'anomalies radiologiques, il faut penser à la bronchite aiguë ou une exacerbation de BPCO. En général, l'expectoration est claire ou légèrement colorée, plutôt jaunâtre. Si vous avez une anomalie radiologique, en cas de pneumonie, vous avez une expectoration purulente, parfois rouillée, hémotoïque, accompagnée de dyspnée, de fièvre, de frissons, de douleurs thoraciques, caractéristiques d'une pneumonie.

Lorsque vous avez un abcès, vous avez des expectorations plutôt abondantes et purulentes, vous avez une vomique, vous pouvez avoir une vomique. La vomique, on va la définir tout à l'heure. Parfois, elle n'est pas extériorisée, le patient la ravale, mais vous pouvez demander au patient s'il a un goût de pu dans la bouche.

C'est facilement reconnaissable. La coqueluche donne surtout une expectoration abondante, muqueuse, avec des quintes de toux. La tuberculose, la toux est plutôt sèche, puis elle devient productive avec des expectorations muqueuses, plus rarement purulentes lorsqu'il y a une nécroscaseuse qui est abouchée à la branche, avec une altération d'état général.

Un infarctus pulmonaire peut s'accompagner d'une expectoration visqueuse et noirâtre, voire rouge, avec douleurs thoraciques et dyspnées. Il faut rechercher l'embolie pulmonaire. L'expectoration dans un contexte aigu peut être allergique, c'est une expectoration de fin de crise d'asthme, visqueuse et collante, ou translucide et perné.

Et si vous avez une insuffisance cardiaque gauche, l'expectoration est plutôt abondante, mousseuse et aérée, blanchâtre ou rosée, parfois hémoptoïque, suite à une toux parfois quinteuse. Elle est accompagnée d'une dyspnée avec une orthopnée, caractéristique de l'insuffisance ventriculaire gauche. Dans les expectorations chroniques, lorsque vous n'avez pas d'anomalie radiologique, il faut rechercher la bronchite chronique du sujet tabagique, qu'on a déjà définie, ou bien un sujet asthmatique sévère, une expectoration muqueuse chronique.

Lorsque vous avez des anomalies radiologiques, vous pouvez avoir des dilatations des bronches, les expectorations sont alors purulentes ou mucopurulentes, surtout matinales. Vous pouvez avoir une tuberculose active ou séculaire, avec une expectoration muqueuse chronique parfois purulente, soit en phase aiguë lorsque vous avez une necroscase, soit en phase

chronique lorsque vous avez une surinfection sur des bronchectasies séculaires de tuberculose. Vous pouvez avoir des cystes pulmonaires infectées, ça donne en général des expectorations purulentes, un petit peu comme les abcès.

Dans les carcinomes bronchio-alvéolaires, ou ce qu'on appelle actuellement carcinome lépidique, vous pouvez avoir une expectoration chronique spumeuse, en forme d'écume, et vous pouvez retrouver à la cytologie des cellules cancéreuses. On va passer à la vomique. Vous avez plusieurs caractéristiques de la vomique.

Selon la quantité, lorsqu'elle est massive, supérieure à 100 millilitres, c'est une grande quantité de pus évacuée brutalement, lorsque vous avez de gros abcès pulmonaires. C'est une douleur vive, accompagnée volontiers d'angoisse et d'asphyxie, en fonction du volume de votre abcès. Cette vomique peut être fractionnée, quelques dizaines de millilitres plusieurs fois par jour, et elle peut s'installer de façon brutale, d'un jour à l'autre, sur un malade sain.

En général, ce sont des malades qui font des pneumonies. Vous n'avez pratiquement pas d'expectorations, et progressivement, ces pneumonies vont s'organiser en abcès, et vous pouvez avoir progressivement, ou de façon brutale, l'évacuation d'une grande quantité de pus, c'est la vomique. Ou ce qu'on appelle les vomiques numulaires, en pièces de monnaie, c'est des rejets à intervalles rapprochés de gros crachats.

Donc tous les cas de figure sont possibles, mais recherchez cette grande quantité de pus que le patient va rejeter par la bouche, et qui est très, très évocatrice d'abcès pulmonaires. Une vomique purulente est très évocatrice d'abcès pulmonaires, et une vomique eau de roche est évocatrice plutôt d'un kyste hidaïque. On peut retrouver également du pus dans les vomiques hidaïques, mais en général, en général, c'est de l'eau de roche, sauf lorsque ça se surinfecte.

Et on retrouve fréquemment avec le pus la présence de membranes hidaïques, ce qu'on appelle les membranes en peau de raisin. Quelles sont les causes de vomique ? On les a un petit peu explorées. Les causes pulmonaires, vous avez surtout les abcès pulmonaires et le kyste hidaïque pulmonaire.

Les causes pleurales, vous pouvez avoir une plûrésie purulente qui est rompue dans les bronches. Vous pouvez avoir une vomique, d'accord ? Des plûrésies qui sont compliquées. Le pus de la plèvre peut être expectoré, lorsque vous avez une fistule broncho-pleurale.

Vous pouvez avoir des causes médiastinales, une collection liquidienne, par exemple, d'un kyste bronchogénique, qui est congénital, ou un disembryome rompu dans les bronches. C'est un peu plus rare. Et puis, on peut avoir des causes sous-diaphragmatiques, comme des abcès sous-diaphragmatiques, ou des kystes hidaïques hépatiques, qui communiquent, là encore, avec les bronches.